

CRISE HIPERTENSIVA — LOA DEFINE A CONDUTA

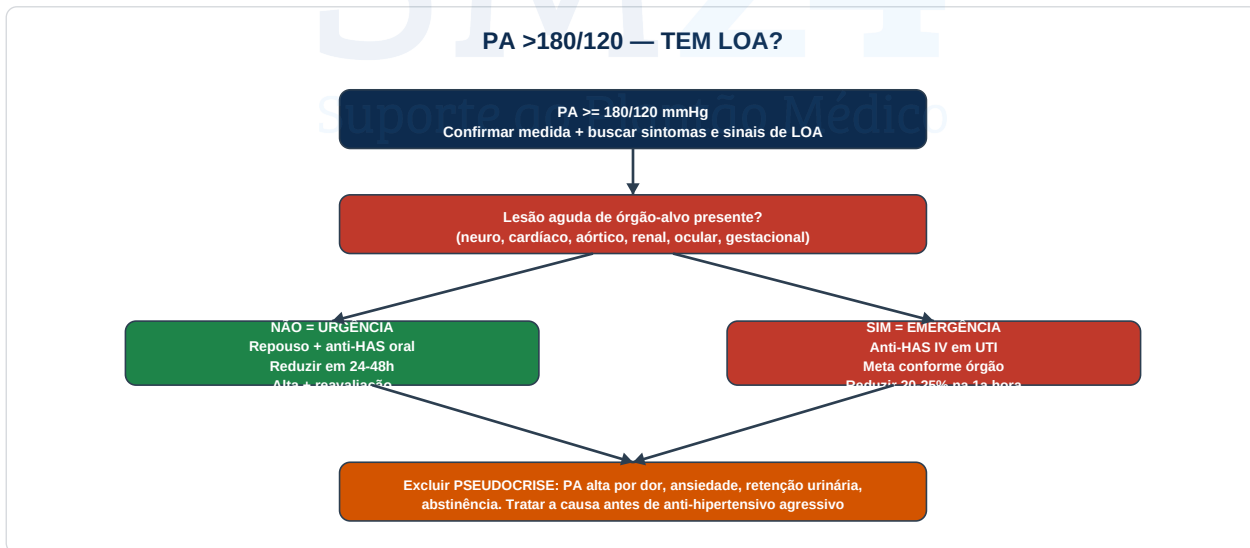
URGÊNCIA vs EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

Aspecto	Urgência	Emergência
Definição	PA muito elevada (geralmente >180/120) SEM lesão aguda de órgão-alvo	PA muito elevada COM lesão aguda de órgão-alvo (LOA) em curso
Sintomas	Assintomático ou sintomas inespecíficos (cefaleia leve)	Sintomas de LOA: dor torácica, dispneia, déficit neurológico, oligúria
Via de tratamento	Anti-hipertensivo ORAL, reduzir em 24-48h	Anti-hipertensivo IV em ambiente monitorado (UTI)
Meta de PA	Reduzir gradualmente; não normalizar rapidamente	Reduzir 20-25% na 1a hora (exceto AVC/dissecção — regras próprias)
Local	Observação no PS, alta com ajuste e reavaliação ambulatorial	Internação / UTI
Risco da queda rápida	Hipoperfusão (AVC, isquemia) se reduzir demais	Mesma regra: queda abrupta agrava isquemia de órgão

LESÕES AGUDAS DE ÓRGÃO-ALVO (LOA) — DEFINEM EMERGÊNCIA

Órgão	Emergência hipertensiva	Pista clínica
SNC	Encefalopatia hipertensiva, AVC isquêmico/hemorragico, HSA	Cefaleia intensa, confusão, déficit focal, convulsão, papiledema
Coração	SCA, edema agudo de pulmão, IC aguda	Dor torácica, dispneia, estertores, B3
Aorta	Dissecção aórtica aguda	Dor torácica/dorsal lancinante, assimetria de pulsos/PA
Rim	Lesão renal aguda, hematúria, proteinúria nova	Oligúria, creatinina em ascensão
Olho	Retinopatia grau III/IV (hemorragias, exsudatos, papiledema)	Borramento visual, fundoscopia alterada
Gestação	Pré-eclâmpsia grave / eclâmpsia (> 20 semanas)	Cefaleia, escotomas, epigastralgia, plaquetopenia

ABORDAGEM DA PA MUITO ELEVADA NO PS



DROGAS IV NA EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

Rx ESCOLHER PELA SITUAÇÃO CLÍNICA

Nitroprussiato de sódio: 0,3-10 mcg/kg/min IV — potente e titulável; cuidado com intoxicação por cianeto/tiocianato em uso prolongado ou renal

Nitroglicerina: 5-200 mcg/min IV — preferida em SCA e edema agudo de pulmão (venodilatação, reduz pré-carga)

Esmolol: 0,5 mg/kg bolus + 50-300 mcg/kg/min — betabloqueador de ação ultracurta; ideal na dissecação (associado a vasodilatador)

Metoprolol: 5 mg IV lento, repetir até 15 mg — controle de FC na dissecação/SCA

Labetalol: 10-20 mg IV bolus, repetir; ou 0,5-2 mg/min — alfa+beta; útil em emergência neurológica e gestação

Hidralazina: 5-10 mg IV — opção na gestante (eclâmpsia); evitar isolada na dissecação (taquicardia reflexa)

Nicardipina/Clevidipina: BCC IV tituláveis — boa opção em emergência neurológica

Dissecação aórtica: PRIMEIRO betabloqueador (FC alvo <60), DEPOIS vasodilatador; PAS alvo 100-120 mmHg

METAS POR SITUAÇÃO — NÃO É IGUAL PARA TODOS

ALVO DE PA DEPENDE DO ÓRGÃO ACOMETIDO

- Dissecação aórtica: PAS 100-120 mmHg e FC <60 em <20 min (a mais agressiva) — betabloqueador antes do vasodilatador
- AVC isquêmico SEM trombólise: só tratar se PA >220/120; com trombólise: manter <185/110
- AVC hemorrágico: reduzir PAS para ~140 mmHg de forma controlada
- Edema agudo de pulmão / SCA: nitroglicerina + reduzir pós-carga; cuidado com betabloqueador no EAP descompensado
- Eclâmpsia/pré-eclâmpsia grave: hidralazina ou labetalol + sulfato de magnésio; meta 140-150/90-100
- Encefalopatia hipertensiva: reduzir 20-25% na 1a hora, reversível com a queda da PA

PSEUDOCRISE E ERROS COMUNS

Pseudocrise Hipertensiva

- PA muito elevada secundária a um gatilho, sem LOA
- Causas: dor, ansiedade/pânico, retenção urinária, abstinência, sono ruim
- Conduta: tratar a causa (analgesia, sondagem, ansiolítico) e reavaliar
- Anti-hipertensivo agressivo é desnecessário e pode causar hipotensão
- Repouso 30-60 min muitas vezes normaliza a PA

Erros a Evitar

- Nifedipino sublingual: PROSCRITO — queda abrupta e imprevisível, risco de AVC/IAM
- Tratar 'número' de PA sem buscar LOA nem sintomas
- Normalizar a PA rapidamente na urgência (risco de hipoperfusão)
- Alta sem ajuste de medicação e sem reavaliação programada
- Não investigar causa secundária em jovem ou crise recorrente

CONDUTA E SEGUIMENTO

FECHAMENTO DO CASO

- ☐ Confirmar PA em ambos os braços, manguito adequado, paciente em repouso
- ☐ Buscar ativamente LOA: ECG, troponina se dor torácica, fundo de olho, creatinina/EAS, exame neurológico
- ☐ Emergência: IV em ambiente monitorado (UTI); urgência: oral e observação
- ☐ Reduzir gradualmente (exceto dissecção) — evitar hipoperfusão
- ☐ Alta da urgência: retomar/ajustar anti-hipertensivo, orientar sinais de alarme, reavaliação em 24-72h
- ☐ Investigar HAS secundária se jovem, refratária ou crises recorrentes



FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com PA 210/130 mmHg, assintomático, sem sinais de lesão de órgão-alvo. Qual a conduta correta?

- A) Nifedipino 10 mg sublingual imediato
- B) Nitroprussiato IV em UTI para normalizar a PA
- C) Urgência hipertensiva — anti-hipertensivo oral, repouso e redução gradual em 24-48h, com reavaliação
- D) Internar para reduzir a PA a menos de 120/80 em 1 hora
- E) Alta imediata sem qualquer ajuste

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Homem com dor torácica lancinante irradiando para o dorso, PA 200/120 no braço direito e 150/90 no esquerdo. Qual o alvo e a sequência terapêutica?

- A) Vasodilatador isolado (nitroprussiato) para normalizar a PA
- B) Betabloqueador (FC <60) primeiro, depois vasodilatador; PAS alvo 100-120 mmHg
- C) Hidralazina IV para reduzir a pós-carga
- D) Reduzir a PA apenas se ultrapassar 220/120
- E) Nifedipino sublingual

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que o nifedipino sublingual é proscrito no manejo da crise hipertensiva?

- A) Porque não reduz a pressão arterial
- B) Porque causa queda abrupta e imprevisível da PA, com risco de AVC e isquemia miocárdica
- C) Porque eleva a frequência cardíaca de forma benéfica
- D) Porque só age após 24 horas
- E) Porque é contraindicado apenas em idosos

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente com PA 195/115, agitado, com retenção urinária e bexigoma. Qual a conduta inicial mais adequada?

- A) Nitroprussiato IV imediato
- B) Reconhecer pseudocrise — aliviar a retenção (sondagem) e reavaliar a PA
- C) Internar em UTI para controle pressórico
- D) Captopril 25 mg e alta imediata
- E) Furosemda IV em bolus

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Em uma emergência hipertensiva por encefalopatia hipertensiva, qual a meta de redução da PA na primeira hora?

- A) Normalizar a PA (menos de 120/80)
- B) Reduzir 20-25% da PA na primeira hora
- C) Reduzir 50% da PA na primeira hora
- D) Não reduzir até realizar tomografia
- E) Reduzir apenas a diastólica para menos de 60

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

PA muito elevada SEM lesão de órgão-alvo = urgência hipertensiva. Tratamento com anti-hipertensivo oral, repouso e redução gradual em 24-48h, com reavaliação ambulatorial. Reduzir rapidamente (IV) é desnecessário e arriscado (hipoperfusão).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Quadro de dissecção aórtica (dor lancinante para o dorso + assimetria de PA). Meta mais agressiva: PAS 100-120 mmHg e FC <60. Sequência: betabloqueador PRIMEIRO (reduz dP/dt e a força de cisalhamento) e depois vasodilatador — evita taquicardia reflexa que propaga a dissecção.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O nifedipino sublingual causa queda abrupta, intensa e imprevisível da PA, com risco de hipoperfusão cerebral (AVC) e coronariana (IAM). Por isso está proscrito. Prefere-se redução controlada com drogas tituláveis.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Trata-se de pseudocrise hipertensiva: a PA está elevada por um gatilho (retenção urinária com bexigoma). A conduta é tratar a causa (sondagem vesical) e reavaliar — a PA costuma normalizar sem necessidade de anti-hipertensivo agressivo.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Na maioria das emergências hipertensivas (incluindo encefalopatia hipertensiva), a meta é reduzir 20-25% da PA na primeira hora, de forma controlada. Exceções com regras próprias: dissecção aórtica (mais agressiva) e AVC (limiares específicos).

SM24
Suporte ao Plantão Médico